写给抽烟的人，也写给每天闻得到烟的人

一根烟的事

吸烟、二手烟、三手烟，
以及那句「关你什么事」。

午休，三楼尽头的厕所。门一推开，一股温热的、混着消毒水的气味扑出来。最里面那个隔间亮着灯，门底下漏出一线光；红光一亮一暗，很规律。

你洗了手，四十秒，出来。走到楼梯口，鼻腔里还是那股味。

这件事小到不值得写一本书。它每天都在发生，发生完就散了，没人受伤，没人报警。

但它背后站着一句话，那句话值得写一本书——

> 我抽我的，关你什么事。

说这句话的人，多半不是耍横。他是真心这么想的：烟进了我的肺，钱从我口袋里出，后果我自己担。听起来，这是一笔只涉及一个人的交易。

这本书想说清楚的是：这笔交易里还有别人。不是道德意义上的「别人」，是物理意义上的——空气是共用的，墙是共用的，衣服和头发也是。

所以它不劝人。它只做三件事：把一根烟烧出来的东西列清楚；把「我抽我的」这句话里漏掉的部分补上；给已经在抽的人，和天天在闻的人，各留一条能走的路。

说明　这些话凭什么信

数字有出处	每个数字后面都标了来源。查不到出处的，宁可不写——这本册子里的数字不多，但都能对回去。
不评判人	不写「你应该」，也不写「你没救」。成瘾是生理机制，不是品格缺陷；这本书骂的是烟，不是抽烟的人。
不够就说不够	戒烟难就是难，电子烟的证据就是还没那么硬。含糊的地方会直接说含糊，不拿一个漂亮结论糊过去。

有出口	最后一章给的是能立刻用的做法——离开、站位、说话的三个版本、往哪儿反映。不是一句「请远离烟草」。

还有一句要提前说：这本书里没有一件事是必须做的。它把账算给你看，怎么选是你的事。

用法 三句话

可以跳	七章各自独立。想先看结论，翻第五章；只想知道怎么躲开，翻第七章。**它是一本可以查的册子，不是一本要读完的书。**
先看数字	第二章讲别人吐出来的烟，第五章讲自己点烟的那只手。这两章的数字最硬，也最容易被记住。
要打出来	A4，页码在页脚，封面这张索引里的页码和正文对得上。打印出来传着看，比在群里发一个链接有用。

入口 你现在最想弄清楚哪件事

一根烟到底烧出了什么 4

第一章 · 两股烟，不是一回事

厕所、楼道、包间里那股散不掉的味 6

第二章 · 二手烟与「没有安全水平」

外套上的烟味，回家抱了一下妹妹 9

第三章 · 三手烟，烟散了东西还在

「电子烟没事吧，这个没焦油」 11

第四章 · 换了个壳，没换掉尼古丁

「我知道有害，但就是戒不掉」 13

第五章 · 七到十秒，和五种说法

戒了几次，都没成 16

第六章 · 工具，而不是意志力

我不抽烟，但天天被迫闻 19

第七章 · 四个动作，三句话

最后：如果只记一页

结语 · 八个最值得带走的数字

一句说明。这本册子是科普，不是诊断，也不是处方。戒烟药物属于处方药，未成年人用药必须由医生评估。持续咳嗽、胸闷、喘不上气，去医务室或者医院——那里的医生能看到你，这本册子看不到。

第 一 章

一根烟烧出了什么

> 烟叶里没有七千种化学物质。它们是烧出来的。

下班前的楼道拐角，消防栓旁边。一个人背对着墙，手拢着打火机。

火苗舔上烟头的那一下，烟丝先鼓起来，然后塌下去。他吸了一口，把烟夹在指间，垂在身侧。

接下来八分钟，他没再吸几口。烟就那样夹着，自己烧。

灰落在地上，一小截一小截。

写字楼四层，下班前十分钟

大部分人以为烟是「被吸掉」的。其实一支烟烧完的十分钟里，被吸进去的只有八到十口，加起来不到一分钟。剩下那九分钟，它夹在手上、搁在烟灰缸边、竖在窗台上，自己烧。

这九分钟有个名字，叫阴燃。

搞清这根烟在干什么，得从它被点着的那一秒开始。

1.1 燃烧是制造，不是释放

烟叶里主要是纤维素、糖、蛋白质、生物碱。这些东西本身谈不上多毒。但火一上来，温度、缺氧、干馏同时发生，分子被拆开又重组，出来的是另一批东西。

一支烟烧完，能检出七千多种化学物质，其中至少六十九种已知能致癌。这个数字不是危言耸听，是世界卫生组织用了很多年的口径。

关键在于温度。吸烟的时候，燃烧端能到 900℃；不吸的时候，它只是阴燃，600℃ 左右。温度低，氧气又不够，燃烧就不完全——不完全燃烧的产物，比充分燃烧更复杂，也更难对付。

所以烟不是「从烟叶里跑出来的」。它是被现场做出来的。

1.2 两股烟，不是一回事

同一支烟，其实在冒两股烟。

主流烟是你吸进去的那口。它经过烟丝、经过滤嘴，温度高，燃烧相对充分。

侧流烟是烟头自己烧出来的那股。它不经过滤嘴，温度低，缺氧，直接排进空气里。

两股烟的成分不一样。同样一克烟，侧流烟里的一氧化碳约是主流烟的五倍，烟碱三倍，苯并芘四倍，亚硝胺五十倍。而室内二手烟里，侧流烟占了绝大部分——常见的估计是八成以上。

主流烟

经过滤嘴，温度约 900℃，燃烧相对充分。

被吸进去，留在吸烟者的肺里。

抽一口，才有一口。

侧流烟

没有滤嘴，约 600℃，缺氧、不完全燃烧。

直接排进房间，占室内二手烟的八成以上。

只要还点着，就一直在冒。

这里有句话得先说清楚，否则上面那组倍数很容易被读歪。

「亚硝胺五十倍」说的是**同样一克烟里谁更毒**，不是「吸二手烟等于吸了五十倍的烟」。吸烟者是把主流烟深深吸进肺里，非吸烟者吸的是被整间屋子的空气稀释过的环境烟，真正进入体内的剂量，通常还是低于吸烟者。

那为什么还要知道这组数？因为它解释了一件很日常的事：为什么「他只抽了一根」和「味道一整天都在」可以同时成立。侧流烟不是一次性事件，是一个持续排放的源头。你闻到的不是残留，是正在进行。

1.3 一间厕所里的浓度

一支烟烧完，能放出十几毫克细颗粒物。听起来不多——十几毫克，一粒米那么重。

但把它放进一间三四平方米、门窗关着、没有对流的厕所，这些颗粒没有地方去。它们悬在空气里，浓度可以冲到几百微克每立方米。作为参照：空气质量二级标准的日均限值是 75。

更麻烦的是颗粒上挂着的东西。尼古丁、亚硝胺、苯并芘、一氧化碳，都搭在这些颗粒上。雾霾天你戴口罩，是因为颗粒；而这里的颗粒，还带着别的货。

一氧化碳值得单独说一句。它会抢在氧气前面跟血红蛋白结合，占掉本该运氧的位置。浓度高的时候，人会闷、头胀、心跳快。这也是为什么从那种厕所出来，除了鼻子难受，还会有一点说不清的疲惫。

1.4 它不会停在点燃的地方

侧流烟的颗粒大多在 1 微米以下。这个尺寸意味着两件事：能进到肺泡，也能跟着气流走很远。

门缝挡不住它。走廊里的穿堂风会带着它走，楼梯间的烟囱效应会把它往上抽，办公室的门开一下，它就进来了。

「我关着门呢」这句话，改变的只是烟在你视线里的位置，没有改变它在你空气里的位置。

> **一句话小结。**点烟这个动作，等于在室内启动一个小型、持续、没有过滤的排放源。它不问你同不同意，也不问这间屋子原来是谁的。

一根烟烧十分钟，真正被吸进去的不到一分钟。剩下九分钟，它烧的是房间。

第 二 章

二手烟：你没抽，但你在吸

> 它不是「淡一点的一手烟」。它是另一种东西。

周六下午，家里的客厅。舅舅坐在沙发上，茶几上一只玻璃烟灰缸，里面已经躺了四个烟头。

电视开着，声音很大。他把烟灰弹进缸里，很准，没看。

窗户开了一条缝，窗帘被风吹得轻轻动。烟往上走，走到窗帘那儿，散开，然后往下沉。

你在另一头写作业，写着写着，眼睛开始发涩。

周六下午，家里的客厅

窗开了。烟还是往你这边走。

这件事很多人都经历过，但很少有人把它当成一件「有机制」的事——多数人只当它是气味问题，忍一忍，或者起身走开。忍一忍当然可以，但如果要判断「值不值得为这个翻脸」，得先知道自己在忍什么。

2.1 它到底是什么

二手烟是两样东西的混合物：烟头自己烧出来的侧流烟，加上吸烟者呼出来的那一部分主流烟。前者占大头。

它不是「一手烟被空气稀释后的版本」。稀释改变的是浓度，不改变成分。七千多种化学物质还在，六十九种致癌物还在，只是被摊薄了。

而且颗粒变小了。新鲜的主流烟颗粒偏大，一部分会沉在口腔和上呼吸道；飘在空气里的二手烟颗粒大多在 1 微米以下，能一路进到肺泡。这也是为什么它对心血管的影响，比对肺的影响来得更快。

世界卫生组织的说法是：烟草烟雾可以在室内空气中停留最长五个小时。五个小时是什么概念——早上有人抽了一根，午饭时这间屋子里的空气还没有换干净。

2.2 「没有安全水平」是什么意思

这句话经常被误读。有人听成「一点点就有事，那干脆无所谓」，也有人听成「只要没到某个量就没事」。

它真正说的是：风险随着暴露量连续上升，找不到一个「低于它就没有额外风险」的阈值。代价从第一口就开始累积，没有一条「还没到线」的安全区。

最硬的证据不在几十年后的肺癌，而在三十分钟内。健康年轻人暴露于二手烟三十分钟，超声测出来的冠状动脉血流储备就会下降——血管扩张的能力变差，而且是在你完全没感觉的情况下。这不是「心理作用」，是仪器能看见的改变。

短时间暴露还会带来：眼、鼻、咽喉的刺激，心率上升，血小板更容易聚集，血管内皮功能受损。这些都不算病，但它们都是通向病的路。

2.3 这件事在中国有多大

23.2%
15 岁及以上人群现在吸烟率，男性 43.9%
2024 年中国成人烟草调查

68.1%
不吸烟者的二手烟暴露率，约 7 亿人
2018 年中国成人烟草调查

50.9%
室内工作者过去 30 天在工作场所看到有人吸烟
2018 年中国成人烟草调查

数据来源：中国疾病预防控制中心；《中国吸烟危害健康报告 2020》。

第三个数字值得停一下。它不问「你抽不抽」，问的是「你这一个月里，有没有在工作的地方看见别人抽」。一半的人回答有。

同一份调查里还有两个数字：44.9% 的人说，自己家里有人吸烟；二手烟暴露最严重的室内场所是网吧（89.3%）、酒吧和夜总会（87.5%）和餐馆（73.3%）。

这说明二手烟不是一个「外面的世界」的问题。它就在你上班的楼道里，在你吃饭的馆子里，在你住的那栋楼里。

2.4 长期的账，不只是肺癌

长期暴露于二手烟的不吸烟者，肺癌风险升高约 20%–30%，冠心病风险升高约 25%–30%。这两个区间来自美国卫生总监报告，也是世界卫生组织反复引用的口径。

对小孩，账来得更快：哮喘加重、中耳炎、下呼吸道感染；婴儿还可能增加猝死综合征的风险。对孕妇，是低出生体重和早产。

对年轻人，最近的那笔账其实很朴素：哮喘的人更容易发作，跑步更容易喘，感冒好得更慢，在一间有人抽烟的屋里待一下午，会头沉。这些都不够去医院，但它们是你每天都在付的利息。

2.5 通风为什么不管用

这是最常被拿来辩解的一条：「我开着窗呢」「有排风扇」。答案是：有用，但不够，而且在有些情况下几乎没用。

美国采暖、制冷与空调工程师学会（ASHRAE）的结论很直接：通风和空气净化无法把二手烟降到安全水平，唯一有效的室内措施是禁止吸烟。这个协会是暖通行业的专业组织，不是控烟团体——它的立场本来可以更保守。

道理不复杂。净化器有一个固定的洁净空气量，而烟的排放是连续的。你可以换掉空气，换不掉源头。只要那根烟还在烧，屋子就一直在被重新填满。

开窗的效果，是把浓度从「很高」降到「高」；同时，它把烟送到了下一个人那里——走廊、楼道、隔壁阳台。

厕所的排风扇更微妙。它靠负压往外抽，但门一开一关，气流会倒灌；而且多数排风扇的风量，远小于一支烟瞬时释放的量。你以为在排，其实只是搅。

2.6 一根烟的房间

三四平方米，门窗关着，一个人，一根烟。这是最常见的一种暴露场景，也是最容易被低估的——因为它短。几分钟，进去一趟，出来就好了。

但浓度不看时长，看空间。同样的排放量，放在三十平方米的房间里是「有点味」，放在三平方米的厕所里就是「呛」。在这两个地方待同样的两分钟，吸进去的量不是一个量级。

而且烟走了，颗粒还在。细颗粒几乎不沉降，它们会一直飘着，直到被墙、衣服、人的肺接住。下一个推门进来的人，接的是上一根的账。

空气不按根计数。你点一根，它就把这间屋子重新算一遍。

第 三 章

三手烟：烟散了，东西还在

> 味道散了，不等于东西没了。

周日晚上回家，外套搭在椅背上。

周一早上起床，你把外套拿下来，凑近闻了一下领口——一股淡淡的、发甜的烟味，是昨天在舅舅家沾上的。

你把它抖了抖，挂到窗外吹了十分钟。再闻，还有。

家里，周一早上六点二十

那股味不是「还没散」。它是「还在」。

烟熄灭之后，一部分物质继续飘在空气里，慢慢被稀释；另一部分落了下来，落在墙上、窗帘上、沙发上、衣服纤维里、头发上、皮肤上。这一层，有个名字叫三手烟。

它不是气味。气味只是它还在挥发的证据。

3.1 尼古丁是黏的

烟里含量最多的有机物之一是尼古丁。它以蒸气的形式被释放出来，然后几乎全部沉降在室内表面上。沉降之后，它不会很快消失——在墙面、织物、灰尘里，可以存留数周到数月。

这就是为什么有些房间「一进去就知道有人抽烟」，哪怕窗户开了一整天。味道的来源不是空气，是表面。空气换掉了，表面还在往外释放。

衣服和头发更麻烦，因为它们是移动的。你穿着那件外套坐进办公室、坐上公交车、回到家抱起妹妹，表面上的东西就跟着你走了一路。

3.2 它还会继续变毒

如果只是「残留的尼古丁」，事情还不算最糟。真正麻烦的是，它会接着反应。

2010 年《美国国家科学院院刊》（PNAS）上有一项研究：附着在室内表面的尼古丁，会和空气里的亚硝酸反应，生成烟草特有亚硝胺（TSNA），其中包括 NNK 和 NNN——这两个都是国际癌症研究机构列为 1 类的致癌物。

实验里，把沾了二手烟的材料放在亚硝酸环境中三个小时，表面的 TSNA 增加了十倍以上；还检出了一种新鲜烟雾里根本没有的物质 NNA。也就是说，残留物没有慢慢变淡，它在变成另一种东西。

亚硝酸从哪来？燃气灶、燃气热水器、汽车尾气。所以车里和厨房边上，是这个反应最容易发生的地方。

3.3 三个常见的误会

「开窗吹吹就好了」

通风带走的是空气里的，带不走表面上的。表面还在，就还在往外释放。

「我去外面抽」

比在室内抽好。但皮肤和衣服上的残留会跟着你回来，落在沙发上、床上、孩子身边。

第三个误会是「烟味没了就没事了」。嗅觉的阈值远高于仪器的检出限——你闻不到的时候，东西往往还在。鼻子是个很灵敏的报警器，但它不是检测仪。

3.4 谁最吃亏

婴幼儿。他们在地上爬，手抓到什么都往嘴里放，体重又小，同样的残留量，按体重算下来暴露高得多。这也是为什么三手烟的研究，最早是从儿童哮喘和婴儿健康做起的。

孕妇。尼古丁能通过胎盘，胎儿在宫内就在接触。

最近的一个场景是这样的：你在阳台抽完，回屋，抱了一下三岁的妹妹，她脸贴在你领口。这个动作持续三秒。她吸进去的，是你外套上那一层。

这不是要让人内疚。内疚不解决问题。它只是说明：暴露这件事，不是「开个窗」就能关掉的开关。

3.5 能做的几件小事

外套不进卧室，挂在通风的地方；回家先换衣服、洗手洗脸，再抱小孩。

车里不抽烟。空间小，亚硝酸来源多，座椅和顶棚的织物又特别能存东西。

家里有小孩的：沙发套、窗帘、床单定期洗；别在室内点烟，也别在车里点。这些算不上洁癖。它们只是把暴露量往下压——压不到零，但能压掉一大截。

烟味不是「还没散」，是「还在」。你闻到的每一次，都是它在提醒你它没走。

第 四 章

电子烟：换了个壳

> 它没有在燃烧。但它仍然在给药。

合租屋的客厅，十一点。茶几上放着一个奶茶杯形状的东西，蓝光亮了一下。

坐在沙发那头的人吸一口，屏住，几秒后吐出来，一团白雾在暗里散开，很快没了。

「没事，这个没焦油。」他说。

雾散得很快。味道是甜的，像某种饮料。

合租屋，晚上十一点

「没焦油」这句话是真的。卷烟燃烧产生焦油，电子烟不燃烧，所以没有焦油。

但「没有焦油」不等于「只有水」。它换了一套产物，没有取消产物。

4.1 不是水蒸气，是气溶胶

电子烟加热的是一种溶液：丙二醇、甘油、尼古丁、香精。加热之后出来的东西，物理上叫气溶胶——液体微粒悬浮在气体里，不是水蒸气。

这些微粒小到能进肺泡。而加热这个过程本身，会产生新的物质：甲醛、乙醛、丙烯醛，来自丙二醇和甘油的热解；镍、铬、铅，来自发热丝和金属管路；还有部分调味剂里的双乙酰，长期吸入与闭塞性细支气管炎有关。

中国疾控中心的说法是：电子烟气溶胶可能含有致癌化学物质、挥发性有机化合物、可深入肺部的超细颗粒，以及镍、锡、铅等重金属。

4.2 国标管住了什么，没管住什么

2022 年 10 月 1 日，《电子烟》强制性国家标准（GB 41700-2022）实施。它管住了几件要紧的事：

1. **口味**
   不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味。水果味、饮料味、糖果味的电子烟，不再允许生产和销售。

2. **尼古丁**
   雾化物应含有烟碱；烟碱浓度不高于 20 mg/g，总量不高于 200 mg。不含尼古丁的「草本雾化」也不得作为电子烟销售。

3 **温度与释放物**

雾化区域温度不高于 350℃；对释放物中的甲醛、乙醛、丙烯醛设了限量；产品要有童锁。

这些是底线，不是「无害认证」。国标的意思是「合格产品至少不能想加什么就加什么」，不是「合格产品可以放心吸」。

而且现实里还有另一层。形似奶茶杯、可乐罐的三无产品，仍在微商和小店流通；标着「0 尼古丁」的，检测出来照样有；没有成分表，没有童锁，没有抽检。国标管得住持证企业，管不住朋友圈。

4.3 它是门，不是出口

《中国吸烟危害健康报告 2020》引了一项纳入 91051 名青少年的 Meta 分析：使用过电子烟的青少年，后来成为卷烟使用者的风险，是从不使用者的 2.21 倍。

这个数字容易被误读成「电子烟导致吸烟」。更准确的读法是：它是一条常见路径。尼古丁成瘾先建立，吸的动作先被训练，同伴圈子先重叠，然后「我能控制」这个判断被反复确认——直到某天有人递过来一根真的。

2019 年的中学生调查里，普通高中现在使用电子烟的比例是 2.2%，职业学校是 4.5%，职校男生 7.1%。绝对数不算高，但趋势是向上的：初中生「听说过电子烟」的比例，五年里从 45% 涨到了 69.9%。

4.4 那它能用来戒烟吗

这是电子烟最有争议的地方，也是这本书最该说实话的地方。

世界卫生组织的立场是：在群体层面，目前没有足够证据支持把电子烟当作戒烟工具。它担心的不是个别人拿它过渡，是人群尺度上的长期双持。

但个体层面的证据要细一些。2024 年的 Cochrane 综述认为，尼古丁电子烟在帮助成年人戒烟上，比尼古丁替代疗法（贴片、咀嚼胶）略有效，证据质量中等；而且多数成功案例，同时接受了行为支持。

翻译成人话：它可能对一部分人有帮助，但不是「随便买一个就能戒」的东西。把它当戒烟工具，得放在医生或戒烟门诊的框架里用；自己买来一边抽卷烟一边抽它，那叫双持，两种产品的危害叠加。

对未成年人，这件事没有讨论空间：尼古丁影响发育中的大脑，注意力、学习、情绪调节都会受影响，而戒断比成年人更难。

换壳不换账。尼古丁还是那个尼古丁，只是换了一种送法。

第 五 章

为什么明知有害还抽

> 不是不知道。是知道了，仍然觉得它不会落在自己身上。

加班到九点，小区门口的花坛边。三个人蹲着，一个人从兜里摸出烟盒，抖出一根，递过去。

「不抽了，我女朋友发现了要打死我。」

「就一根。」

他接了。点着，吸了一口，咳了两下，然后把烟夹在手里，看着它烧。

加班后的晚上，小区门口

「就一根」是这件事最常见的入口。它之所以有效，不是因为它是真的，是因为它听起来像真的——一根确实不会让人得肺癌，一根确实不会上瘾。

问题在于，说这句话的人，通常已经在说第二十次「就一根」了。

这一章不讨论「该不该」，只拆解「为什么」。因为如果不搞清这台机器怎么运转，所有的劝都只是在跟它的外壳说话。

5.1 七到十秒

尼古丁吸入后，七到十秒到达大脑。这个速度比静脉注射还快。

它作用于奖赏回路，多巴胺上升，人会觉得松了一下、定了一下。同时，大脑开始调整：尼古丁受体上调，同样一支烟带来的满足感变少。于是需要更多、更频繁，才能拿到最初那个感觉。

尼古丁在血里的半衰期大约两小时。两小时后，浓度下去，戒断上来：烦躁、注意力散、手空、坐不住、看什么都不顺眼。

于是有了「饭后一根」「休息时一根」「睡前一根」。这些不是习惯，是补货。

这里有一个关键的反转，值得慢慢读一遍：

> 「抽烟解压」测到的，是戒断焦虑的缓解，不是压力本身的下降。尼古丁先制造了那些症状，再负责缓解它们。

这不是说抽烟的人矫情。戒断是真的难受，难受到影响做事、影响睡觉。但要知道难受的来源——它不是你本来就这么焦虑，是你上一次吸进去的东西在退潮。

每一根烟，都在把基线往下压一点。然后你需要下一根，才能回到「正常」。所谓「放松」，其实是回到不难受的状态；而那个不难受的状态，不抽烟的人一直都有。

5.2 五种说法，各漏了什么

下面这五句，是这件事里最常听见的。它们不是谎话，每一句都有一小块是真的。问题在于，每一句都漏掉了另一半。

说法	它漏掉了什么
「我抽得少，一天就三五根。」	心血管风险在低剂量就开始上升，没有一条「安全线」；而且「少」通常会随时间变多。间歇吸烟同样会成瘾，戒断反应一样不少。
「我爷爷抽到九十岁。」	这是幸存者偏差。你看见的是活到九十的那个，没看见的是没活到的。群体风险是 2–3 倍，个体结果无法预测——这两件事可以同时为真。
「压力大，没办法。」	尼古丁本身在制造压力。一支烟的缓解大约维持半小时到两小时，之后是更低的基线。用烟对付压力，是把压力换成另一种压力。
「电子烟没事，这个没焦油。」	气溶胶里仍有尼古丁、甲醛、重金属；而且它是卷烟的门。没有焦油，不等于没有代价。
「我抽我的，关你什么事。」	这句话的前提是「烟只在我肺里」。但八成以上的烟排进了空气，一部分留在墙和衣服上。边界不在你的肺，在别人的鼻子。

前四条，是跟自己算账；第五条，是跟别人算账。

跟自己算账的那四条，可以争——账本在你手里，你怎么权衡是你的事。第五条没法争。账本可以谈，排放没法谈。

你可以决定自己承担什么。你没法决定别人承担什么——除非你先把烟掐了。而只要它还在烧，这件事就一件都做不到。

5.3 为什么是现在

十几岁到二十出头，是这件事最容易发生的窗口。原因不在意志，在施工进度。

大脑里负责冲动控制、权衡长期后果的那部分——前额叶皮层——要到二十五岁左右才成熟。在这之前，它对「此刻」的权重天然高于「三十年后」。这跟意志无关，是发育顺序。

同时，青少年对尼古丁更敏感：更快成瘾，戒断更难，开始得越早，成年后依赖的概率越高。

还有一层是环境。同伴压力很少是「被逼」，多半是「想被看见」。厕所、楼道、花坛边，是这件事发生的地方——不是因为那里舒服，是因为那里没人管，而且有人一起。

这三件事叠在一起，就构成了一个很不公平的局面：风险最高的时候，判断力还在施工；等判断力建好了，习惯已经在了。

5.4 知道和相信，是两件事

「吸烟有害健康」这句话，印在每一包烟上，印了几十年。它没有失效，它只是没有被相信。

准确地说：人们知道这个事实，但不相信它会落在自己身上。肺癌是三十年后的图片，而「现在合群」「现在松一口气」是此刻的。大脑给此刻的权重，永远高于三十年后。

烟草行业非常清楚这一点。它不需要说服你「吸烟无害」——那太难了。它只需要让危害显得远：远到像别人的事，远到像一个统计数字，远到可以一边看警告一边点火。

反过来，你能做的也只有一件事：把远的拉近。看具体的数字，看具体的人，看具体的那间屋子——三平方米，门关着，一个人，一根烟。

> **这一段不是劝。**如果你现在不打算戒，这本书没有立场要求你。但如果你打算继续抽，至少知道自己在做什么——知道这不是「一根的事」，也不是「只关于我自己的事」。

烟不是压力的解药，是压力的赊账。每一根都在往后推还款日，利息照算。

第 六 章

戒：不是意志力的事

> 戒不掉通常不是「你不行」，是你只带了一件工具。

厕所隔间里，手机屏幕亮着。搜索框里打着「戒烟 方法」，删掉，又打「戒烟 几天 难受」。

外面有人敲门。他把手机塞回兜里，冲了水，出来洗手。

镜子里的自己看了一眼，又低下去。

写字楼厕所，午休

这个画面里没有信息差。他知道吸烟有害，知道该戒，也知道去哪儿搜。他缺的是一次成功的经验。

而「成功」这件事，很少靠一次下定决心完成。

6.1 它是病，不是品格

世界卫生组织的疾病分类里，烟草依赖有独立的编码（ICD-10：F17.2），归在精神与行为障碍项下。这句话的意思是：它有诊断标准，有病理机制，有治疗方法。

也意味着：戒不掉不是「没毅力」，是「没治疗」。

只靠意志力硬戒，一年后的成功率通常只有个位数，常见估计是不足 5%。这不是劝退，恰恰相反——它说明失败是默认结果，成功需要额外的工具。

把这件事当成品格问题，代价很实际：失败一次，人会觉得自己不行；失败三次，就不试了。而归因错了，方法就永远找不对。

6.2 有效的，是一个组合

目前证据最硬的方案，是药物加行为支持。世界卫生组织和中国临床戒烟指南的口径一致：规范的戒烟治疗，可以把成功率提高 1–2 倍。

三类一线药物：

1. **尼古丁替代疗法**
   贴片、咀嚼胶。用少量尼古丁缓解戒断，再逐步减量。非处方可及，但仍建议先咨询医生或药师。

2. **盐酸安非他酮缓释片**
   处方药。作用于与成瘾相关的神经通路，需医生评估，有癫痫史等情况不能用。

3 **酒石酸伐尼克兰**

处方药。部分激动尼古丁受体，既减轻戒断，也降低吸烟的快感。效果在三类里通常最强，同样需医生评估。

行为支持不是「聊聊天」。它包括设定戒烟日、识别触发场景、处理戒断、应对复吸、调整作息。戒烟门诊做的就是这个，热线和小程序做的也是这个。

关键在叠起来，不在选一个。药物处理生理，行为支持处理场景，环境处理诱因。三样都在，成功率才像一个可以期待的数。

6.3 在哪儿找到这些

戒烟门诊。多数三甲医院的呼吸科或控烟门诊设有。微信搜「中国戒烟平台」小程序，可以查附近的门诊并直接挂号。

全国专业戒烟热线：400-808-5531。免费，有人接，可以问「我这种情况该怎么开始」。

12320。卫生热线，可以转戒烟咨询，也可以问本地戒烟门诊的地址。

「中国戒烟平台」小程序。中国疾控中心与世界卫生组织驻华代表处联合推出，含戒烟门诊、戒烟热线、吸烟日记、用药助手。

「在线戒烟」小程序。中日友好医院做的，报名后按节点推送指导，周期约六个半月。

如果你还在上学，还有一条：先去校医室。校医做不了治疗，但能做初筛、能判断要不要转诊。未成年人用戒烟药物，必须由医生评估。

6.4 身体什么时候开始修

戒断难受是真的，但修复也是真的，而且开始得比想象中快。

20 分钟

心率和血压开始下降，回到接近平时的水平。

12 小时

血里的一氧化碳降到接近正常，携氧能力开始恢复。

2 周 – 3 个月

循环改善，肺功能开始上升，走路和爬楼没那么喘。

1 – 9 个月

咳嗽和气短减少，气道里的纤毛重新长出来，开始把积的东西往外清。

1 年

冠心病风险降到持续吸烟者的一半。

10 年

肺癌死亡风险降到持续吸烟者的一半。

15 年

冠心病风险接近从不吸烟的人。

时间线来源：美国疾病控制与预防中心（CDC）、世界卫生组织戒烟获益说明。

这张表最有用的一行，是第二行。十二小时——睡一觉的工夫，血里的一氧化碳就正常了。很多人戒的第一天就觉得「整个人清醒了」，不是错觉。

6.5 复吸不是回到原点

多数成功戒烟的人，都经历过不止一次失败。复吸说明的是「这次的方案不够」，不是「你这辈子戒不掉」。

复盘的时候看三件事：是什么场景触发的（饭后、喝酒、吵架、考试前）；当时手上有什么工具（药、替代品、人）；下次换什么。

把复吸当数据，不当判决。这句话听起来像安慰，其实是方法——因为只有把它当数据，你才会去改方案；当成判决，你只会觉得自己不行。

戒烟不是一场意志力的考试，是一次需要工具的治疗。工具不齐，考不过很正常。

第 七 章

不抽烟的人，能做什么

> 你不需要说服一个抽烟的人。你只需要不让自己成为他的过滤器。

公司楼下的快餐店，靠窗那桌。隔壁桌坐下三个人，其中一个把烟盒放在桌上，抽出一根，点了。

你把餐盘往自己这边挪了挪，没说话。

他们那桌在聊球赛，声音很大。烟从他们头顶飘过来，正好经过你这一桌。

你低头继续吃，吃得比刚才快。

快餐店，午饭

这一章是给不抽烟的人写的。也包括那些「自己不抽，但家里有人抽」的人。

先说一个不太舒服的事实：你改变不了他。至少，不在一顿饭的时间里。所以这一章的重点不在「怎么让他戒」，在「怎么让自己少吸一点」，以及「在什么情况下，值得开口」。

7.1 先分清两件事

你想改变他，还是想保护自己？

这是两条完全不同的路。混在一起，通常两件都做不成：你一边想让他灭烟，一边又不想撕破脸，最后站在那儿吸完了整根，一句都没说。

先选一个。多数时候，先选「保护自己」——因为它可控，而且立刻生效。

7.2 保护自己：四个动作

1. **离开，不谈判**
   厕所、楼道、包间，先出去。你不需要一个理由，也不需要对方同意。「我先出去」是一句完整的话。

2. **站到上风口**
   走廊里看烟往哪边走，你往反方向走；有人在门口抽，别站在门口等。烟是跟着气流走的，站位比距离有用。

3. **别在密闭小空间里忍两分钟**

三平方米的厕所，浓度比大房间高一个量级。两分钟的暴露，不比在外面站半小时少。别用「就一会儿」说服自己。

4 **回家先换衣服**

外套挂在通风处，别搭在床头；洗手洗脸。这一步处理的是三手烟，不是味道。

7.3 说话：三个版本

如果你决定开口，下面三句可以直接用。它们的共同点是：说事，不说人；给台阶，不追责；不追求一次说服。

对朋友、同事

「你抽完再进来，我先出去。」

不评价他，只划自己的边界。这句话最难被顶回来，因为它没有指责。

对长辈、亲戚

「我去阳台待会儿，你们聊。」

把自己移开，不要求对方改变。在饭桌上，这比「您能不能别抽」有效，因为它不制造对抗。

第三句是给公共场所的：「这里不能抽烟。」说规则，不说人；一句就够，不追着讲道理。对方情绪上来，就撤——你要的是空气，不是胜利。

有一句话最好别用：「我闻不惯。」它听起来像挑剔，把一件关于健康的事，降级成了一件关于口味的事。

7.4 结构性的做法

个人的躲闪有上限。要真正改变一个场所，得让规则起作用。

室内公共场所本来就禁烟。《公共场所卫生管理条例实施细则》第十八条规定，室内公共场所禁止吸烟；北京、上海、深圳等地还有更严的地方条例。也就是说，餐馆包间、写字楼楼道、电梯、网吧、公交车厢里的那根烟，本来就不该在那里。

场所不同，找的人也不同：餐馆找店长，写字楼找物业，商场找服务台，居民楼找物业或居委会；公交、地铁、商场这类公共场所，可以直接打 12345。

厕所吸烟还有一层消防问题：纸篓、干手纸、隔板，都是易燃物。这一点在反映问题时，往往比「影响健康」更被重视。

反映的时候给三样东西：时间、地点、频次。比如「周二、周四午休，三楼西侧厕所，通常两三个人」——这比「有人抽烟」有用得多，因为它可以被核查，也可以被安排巡查。

如果你还在上学

教育部要求各级各类学校全面建设无烟学校，教室、宿舍、厕所都在范围内。找班主任、德育处或校医室，匿名也可以；校医做不了治疗，但能做初筛、判断要不要转诊。

7.5 几件不要做的事

不要当场对抗。你面对的可能是一个正在戒断的人，不是一个正在讲道理的人。

不要替对方保密到让自己长期暴露。「别告诉别人」可以答应一次，但不能变成你每天吸二手烟的理由。

也不要把每一次暴露都变成一场道德审判。你不是在争取一个「谁对谁错」的结论，你是在争取一口干净的空气。前者要赢，后者只要走开。

自由是有边界的。你的自由，到别人的鼻子为止。

结 语

回到那间厕所

你洗了手，四十秒，出来。走到楼梯口，鼻腔里还是那股味。

这件事里没有坏人。抽烟的那个人可能刚被领导批了一顿，可能刚跟家里吵完，可能只是想让这十分钟快点过去。他有他的理由，那些理由多半是真的。

但理由是真的，代价也是真的。而且代价不全由他付。

一根烟烧十分钟。九分钟夹在指间，自己烧；不到一分钟，被吸进去。这十分钟里，烟没有停在任何一个肺里——它在空气里，在墙缝里，在别人的外套上，在下一个推门进来的人的鼻腔里。

所以这本书从头到尾，其实只说了三件事：

> 烟不是只烧一个人。
>
> 味道散了，东西还在。
>
> 你能决定的，是让不让自己站在那口气里。

就这些。

依据 这些数字从哪儿来

世界卫生组织烟草与二手烟事实清单；中国疾控中心 2018、2024 年中国成人烟草调查、2019 年中国中学生烟草调查；国家卫健委《中国吸烟危害健康报告 2020》；Sleiman 等，PNAS 2010（三手烟与亚硝胺）；Otsuka 等，JAMA 2001（30 分钟暴露与冠状动脉血流储备）；GB 41700-2022《电子烟》强制性国家标准；美国卫生总监报告 2014；CDC 戒烟获益时间线。**正文里每一个数字都能在这几处找到落点；查不到出处的说法，这本书没有写。**

附 如果只记一页

下面这八个数字，是全书最值得带走的部分。抄在黑板上、印在传单上、发在群里，都够用。

数字	说的是什么	出处
7000+	烟草烟雾里的化学物质种类	世界卫生组织
69	其中已知能致癌的种类	世界卫生组织
85%	侧流烟在室内二手烟里的占比	《呼吸病学名词》；环境烟草烟雾研究
50 倍	侧流烟中亚硝胺浓度相对主流烟	同上（同质量比较，非吸入剂量）
68.1%	中国不吸烟者的二手烟暴露率	2018 年中国成人烟草调查
44.9%	说自己家里有人吸烟的人	2018 年中国成人烟草调查
2.21 倍	青少年用电子烟后转吸卷烟的风险	91051 人 Meta 分析，见《中国吸烟危害健康报告 2020》
100 万+	中国每年因吸烟死亡的人数	《中国吸烟危害健康报告 2020》

最后一句。这本册子不卖东西，也没有要你转发。如果它有用，唯一的用法是：下次推开那扇门的时候，你知道自己在推什么。

一根烟的事 · 吸烟、二手烟、三手烟，以及那句「关你什么事」

本册为健康科普，不构成诊疗建议或用药指导。戒烟药物为处方药，须在医生指导下使用；未成年人用药须由医生评估。持续咳嗽、胸闷、气短，请及时就医。

文中场景是日常生活常见情境的写作化处理，不指向任何具体个人或学校。

v1.0 · 2026-11-02